

1. Introducción y relevancia clínica

La **contusión ocular** corresponde a un **traumatismo cerrado del globo ocular y sus anexos**, generalmente causado por un golpe directo con un objeto romo (pelota, puño, piedra, accidente laboral o automovilístico).

A diferencia de las heridas perforantes, **no existe solución de continuidad de la pared ocular**, pero puede haber **daño severo de las estructuras internas**, desde leves hemorragias hasta desprendimiento de retina o fracturas orbitarias.

Importancia clínica:

- Representa una de las causas más comunes de **pérdida visual traumática unilateral en adultos jóvenes**.
- En el contexto pediátrico y deportivo, es **altamente prevenible** con medidas simples (uso de gafas protectoras).
- En EUNACOM, se pregunta con frecuencia en escenarios tipo: “paciente golpeado por pelota de tenis/fútbol con visión borrosa y pupila irregular”.

Principio clave:

Todo trauma contuso ocular **debe considerarse potencialmente grave** hasta descartarse compromiso del segmento posterior, aumento de presión intraocular (PIO) o hemorragia interna.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo del trauma

El golpe provoca una **onda de choque** que se transmite a través del globo ocular, generando:

- **Compresión anteroposterior** inmediata, seguida de **expansión ecuatorial**.
- Esto puede dañar:
 - **Iris y cuerpo ciliar** → iridodiálisis, hipema, uveítis.

- **Cristalino** → subluxación o catarata traumática.
- **Retina y coroides** → rupturas, hemorragias, desprendimiento.
- **Nervio óptico** → neuropatía óptica traumática.
- **Pared escleral** → ruptura (en traumas severos).

El daño puede ser:

- **Primario:** consecuencia directa del impacto (rotura capsular, hemorragia).
- **Secundario:** respuesta inflamatoria, hipertensión ocular, fibrosis, o isquemia.

2.2 Lesiones más frecuentes asociadas

Estructura afectada	Lesión típica	Características clínicas
Párpados y conjuntiva	Equimosis, laceraciones	Signo externo evidente; puede coexistir con lesión profunda.
Cámara anterior	Hipema (sangre)	Nivel hemático visible; puede aumentar la PIO.
Iris y pupila	Midriasis traumática, iridodiálisis	Pupila irregular, fotofobia.
Cristalino	Catarata traumática, subluxación	Pérdida visual progresiva.
Retina / coroides	Hemorragias, rupturas coroideas, edema de Berlin (contusión macular)	Visión borrosa, escotomas.

Nervio óptico	Neuropatía óptica traumática	Pérdida visual sin hallazgos oftalmoscópicos iniciales.
Pared ocular	Ruptura escleral	Ojo blando, pérdida de cámara anterior → urgencia quirúrgica.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

- Dolor ocular y periocular.
 - Disminución de agudeza visual.
 - Fotofobia, lagrimeo.
 - Sensación de presión intraocular o “ojo lleno”.
 - Diplopía (por daño muscular o fractura orbital).
 - Náuseas o cefalea (por hipema o hipertensión ocular).
-

3.2 Signos clínicos

- **Equimosis periorbitaria** (“ojo morado”).
- **Hiposfagma** (hemorragia subconjuntival).
- **Hipema** (nivel hemático en cámara anterior; se observa con linterna lateral).
- **Irregularidad pupilar** (rotura de esfínter o iridodiálisis).
- **Catarata traumática** (blanqueamiento del cristalino).
- **Movimientos oculares limitados** (fractura de piso orbitario o atrapamiento muscular).
- **Hifema oglobo blando** → sospecha de ruptura ocular (no palpar).

- **Reflejo rojo disminuido o ausente** → hemorragia vítrea o desprendimiento de retina.
 - **DPAR** (defecto pupilar aferente relativo) → neuropatía óptica traumática.
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Características diferenciales
Herida perforante ocular	Solución de continuidad, prolapso de iris, cámara anterior plana.
Uveítis traumática leve	Dolor y fotofobia sin hipema.
Glaucoma agudo	Dolor severo, ojo duro, córnea opaca, sin trauma.
Celulitis orbitaria	Edema y fiebre; movilidad ocular dolorosa.
Fractura orbitario-maxilar (blow-out)	Diplopía vertical, hipoestesia infraorbitaria.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En APS / Urgencia General

1. **Evaluación visual inicial (AV)** de ambos ojos.
2. **Inspección cuidadosa:** sin presionar el globo.
3. **Fluoresceína** solo si no hay sospecha de ruptura ocular.
4. **Medición de PIO** (si globo íntegro).
5. **Fondo de ojo** (si posible): hemorragias, edema macular, desgarros retinianos.

6. **Examen pupilar:** DPAR, forma, reactividad.

4.2 Estudios complementarios

Examen	Indicaciones	Observaciones
TAC de órbitas y cráneo (sin contraste)	Sospecha de fractura, cuerpo extraño, hemorragia retrobulbar.	Examen de elección en trauma cerrado.
Ecografía ocular (modo B)	Evaluar vítreo y retina si medios opacos y globo íntegro.	Evitar si sospecha globo abierto.
Tonometría	Evaluar hipertensión ocular post-hipema.	Contraindicado en sospecha de globo abierto.
Gonioscopía (oftalmología)	Buscar desgarro angular (receso angular).	Se realiza una vez resuelta inflamación inicial.

4.3 Criterios diagnósticos

Diagnóstico clínico basado en:

1. Antecedente de golpe directo con objeto romo.
 2. Signos oculares traumáticos (hipema, midriasis, equimosis, hemorragias).
 3. Agudeza visual disminuida.
 4. Estudios de imagen con evidencia de lesión interna o fractura orbital.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

5.1 Conducta inicial en APS / Urgencia

1. **Medir AV y registrar.**
 2. **No presionar el globo.**
 3. **Analgesia sistémica.**
 4. **Antiemético** (evitar aumento de presión venosa ocular).
 5. **Cabeza elevada 30°** si hay hipema.
 6. **Evitar AAS o AINE** (riesgo de resangrado).
 7. **Escudo ocular protector (no oclusivo).**
 8. **Profilaxis antitetánica.**
 9. **Derivación urgente a oftalmología.**
-

5.2 Manejo específico según hallazgo

Hipema (sangre en cámara anterior)

- Reposo en cama con cabeza elevada.
- Evitar movimientos bruscos, esfuerzo y AAS.
- **Cicloplejico (atropina 1%)** para aliviar dolor ciliar.
- **Colirio corticoide (prednisolona 1%)** bajo indicación oftalmológica.
- Control diario de PIO.
- Hospitalización si hipema total o PIO elevada.

Uveítis postraumática

- **Corticoide tópico + cicloplejico.**
- Control oftalmológico a las 24–48 h.

Catarata traumática

- No requiere manejo inmediato si estable.

- Evaluar cirugía electiva según grado de opacidad y visión residual.

Lesiones de retina o coroides

- **Desprendimiento o ruptura:** cirugía vitreorretiniana urgente.
- **Edema de Berlin:** observación; la mayoría mejora en semanas.

Neuropatía óptica traumática

- Tratamiento controversial: algunos protocolos indican **corticoides EV** en dosis altas; sin evidencia concluyente.
- Evaluación neuro-oftalmológica.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Pronóstico
Hipema total o recidivante	Riesgo de glaucoma secundario o sinequias.	Variable; depende de control de PIO.
Catarata traumática	Opacidad progresiva del cristalino.	Buena si cirugía posterior oportuna.
Desprendimiento de retina	Ruptura retiniana post-trauma.	Grave, requiere cirugía urgente.
Glaucoma postraumático (receso angular)	Daño trabecular → hipertensión crónica.	Puede desarrollarse meses o años después.
Atrofia óptica	Secuela de neuropatía traumática.	Pérdida visual irreversible.

Simpática oftalmía

Uveítis bilateral autoinmune Rara, pero devastadora.
tras trauma.

Pronóstico global:

Depende de:

- Energía del impacto.
- Tiempo a la evaluación oftalmológica.
- Integridad del globo ocular.
- Control de la PIO y prevención de complicaciones secundarias.

En general, las contusiones leves (sin hipema ni lesiones internas) evolucionan favorablemente en pocos días, mientras que los traumas con compromiso retiniano o nervioso pueden causar pérdida visual permanente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Toda contusión ocular con hipema requiere derivación urgente.**
 2. **Evitar AAS o AINEs** (favorecen resangrado).
 3. **Hipema + PIO alta** = riesgo de glaucoma → hospitalizar.
 4. **Midriasis traumática** es signo de daño del esfínter iridiano, no usar pilocarpina.
 5. **Ojo blando o pérdida de cámara anterior** → sospechar ruptura → no tonometría ni presión.
 6. **Diplopía vertical + hipoestesia infraorbitaria** = fractura de piso orbitario.
 7. **Control oftalmológico a largo plazo:** riesgo de glaucoma postraumático años después.
-

Errores comunes

- Palpar el ojo o medir PIO sin descartar ruptura.
 - Usar AINE o aspirina tras trauma con hipema.
 - Omitir control de PIO en hipema.
 - No proteger el ojo con escudo rígido.
 - No derivar a oftalmología en las primeras horas.
 - Subestimar pérdida visual “transitoria”: puede ocultar daño retiniano.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **contusión ocular** es un trauma cerrado del globo, con riesgo de daño interno severo aunque el ojo parezca íntegro.
2. El **hipema** es el signo más característico y sugiere compromiso importante del segmento anterior.
3. El manejo inicial incluye **escudo protector, reposo con cabeza elevada, antieméticos y evitar AAS/AINEs**.
4. Siempre realizar **TAC órbitas** ante sospecha de fractura o cuerpo extraño.
5. Controlar y tratar la **presión intraocular** para evitar glaucoma postraumático.
6. **Derivación urgente a oftalmología** ante hipema, visión disminuida o deformidad ocular.
7. Control prolongado: riesgo de **glaucoma por receso angular** incluso años después del trauma.